Livret du formateur — argumentaire diapo par diapo

Support : diaporama « Accident du travail & maladie professionnelle » (CGT Occitanie, 2 jours). Pour chaque diapositive : le message-clé, les points à développer à l'oral, les références juridiques et l'angle CGT. Les montants, taux et numéros de formulaires sont à actualiser au moment de la session.

Ouverture

Diapo 1 · Page de titre

Message clé : Poser le cadre et la méthode CGT.

À développer :

- Présenter les animateur·rices, le déroulé sur 2 jours et les objectifs.
- Annoncer la méthode : on part du vécu des stagiaires, pas d'un cours magistral.
- Rappeler que la santé au travail est un champ d'action syndicale, pas un sujet « technique » réservé aux experts.

Diapo 2 · Objectifs de la formation

Message clé : Donner le cap et recueillir les attentes.

À développer :

- Lire les six objectifs ; demander à chacun ce qu'il vient chercher et noter au paperboard.
- Préciser qu'à la fin, chacun doit pouvoir accompagner un·e collègue, pas seulement « comprendre ».

Diapo 3 · Programme — 2 jours

Message clé : Montrer la logique : J1 = faire reconnaître, J2 = faire réparer et agir.

À développer :

- Jour 1 : du fait accidentel à la reconnaissance par la CPAM.
- Jour 2 : l'indemnisation, la faute inexcusable, les recours, et le passage du cas individuel à la prévention collective.

JOUR 1 — Comprendre, déclarer, faire reconnaître

Diapo 4 · Intercalaire Jour 1

Message clé : Annoncer le fil de la journée.

À développer :

- Insister : tout commence par un bon réflexe de déclaration ; un dossier mal engagé se rattrape difficilement.

Diapo 5 · Les AT/MP en France (chiffres)

Message clé : Mesurer l'ampleur — et l'ampleur de ce qu'on ne voit pas.

À développer :

- Commenter : près de la moitié des AT sont liés à des manutentions manuelles ; les chutes suivent.
- Les décès au travail ne reculent pas ; les MP augmentent (TMS ~90 %, amiante, affections psychiques).
- Rappeler la sous-déclaration : beaucoup d'AT bénins « passés en maladie », de MP jamais déclarées.

Réf. *Source : Assurance Maladie – Risques professionnels, données 2023 (à actualiser chaque année).*

> **Angle CGT —** Derrière chaque chiffre, des conditions de travail. La sous-déclaration est un transfert de coûts vers la Sécu et les salariés : la combattre est syndical.

Diapo 6 · Un enjeu syndical majeur

Message clé : Dire pourquoi la CGT s'en empare.

À développer :

- La sous-déclaration prive les victimes de leurs droits (soins 100 %, IJ majorées, rente).

- L'invisibilisation masque la réalité du travail et freine la prévention.
- L'employeur a une obligation de sécurité : la faire respecter est un levier.

> **Angle CGT —** « La santé ne se négocie pas. » Faire reconnaître un AT/MP, c'est défendre une personne et rendre visible un risque collectif.

Diapo 7 · L'accident du travail (AT)

Message clé : Trois critères : un fait soudain, une lésion, un lien avec le travail.

À développer :

- Soudaineté : c'est ce qui distingue l'AT de la MP (exposition progressive).
- La lésion peut être physique mais aussi psychique (choc, malaise, agression).
- « Par le fait ou à l'occasion du travail » : la notion est large (pause, déplacement interne, mission).

Réf. *Art. L.411-1 du Code de la sécurité sociale (CSS).*

Diapo 8 · Les trois notions à distinguer

Message clé : AT, trajet et MP n'ouvrent pas les mêmes règles.

À développer :

- AT : fait soudain au travail.
- Accident de trajet : protégé entre domicile et travail (ou lieu de restauration) ; détours admis (covoiturage, nécessités de la vie courante).
- MP : exposition durable à un risque.
- Piège classique : l'accident de mission relève de l'AT (et non du trajet).

Réf. *AT : L.411-1 ; trajet : L.411-2.*

Diapo 9 · La présomption d'imputabilité

Message clé : C'est l'atout maître : la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

À développer :

- Un accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé professionnel.
- C'est à l'employeur de prouver une cause totalement étrangère au travail.
- D'où l'importance de bien situer l'accident (heure, lieu, témoins) dès le départ.

> **Angle CGT —** Ne pas se laisser intimider par les « réserves » de l'employeur : la présomption protège le ou la salarié·e.

Diapo 10 · Intercalaire — Déclarer un AT

Message clé : Passer à la procédure : vite et dans les formes.

À développer :

- Annoncer que le bon réflexe dans les premières heures conditionne tout le dossier.

Diapo 11 · Les délais à respecter

Message clé : 24 h côté salarié, 48 h côté employeur.

À développer :

- Le salarié informe l'employeur dans les 24 h (idéalement par écrit, en gardant une preuve).
- L'employeur déclare à la CPAM dans les 48 h (hors dimanches et jours fériés) : la DAT.
- L'employeur peut joindre des « réserves motivées » : expliquer ce que c'est et comment y répondre.
- La feuille d'accident est remise au salarié : soins pris en charge à 100 %, sans avance de frais.

Réf. *Art. R.441-2 (salarié), R.441-3 (employeur), L.441-5 (feuille d'accident).*

Diapo 12 · Les documents clés

Message clé : Le dossier se gagne sur les pièces.

À développer :

- La DAT (employeur) ; le certificat médical initial (CMI) établi par le médecin.
- Sur le CMI : faire décrire TOUTES les lésions, même mineures — ce qui n'y figure pas sera difficile à rattacher ensuite.
- La feuille d'accident (tiers payant) ; les certificats de prolongation puis le certificat final.
- Depuis le 1er septembre 2025 : nouveaux Cerfa sécurisés obligatoires (les anciens sont rejetés).

Angle CGT — Conseil : tout dater, tout conserver (copies). Un dossier, ça se constitue dès le premier jour.

Diapo 13 · Si l'employeur refuse de déclarer

Message clé : La défaillance de l'employeur ne fait pas perdre les droits.

À développer :

- Le salarié peut déclarer lui-même l'AT à la CPAM dans un délai de 2 ans.
- Réunir témoignages, écrits, éventuelle main courante ; informer le CSE et, si besoin, l'inspection du travail.

Angle CGT — Rôle de l'UD : ne jamais laisser un·e salarié·e seul·e face à un refus de déclaration.

Diapo 14 · L'instruction par la CPAM

Message clé : Des délais encadrés — à surveiller de près.

À développer :

- 30 jours francs pour statuer dans le cas simple.
- En cas de réserves ou d'investigation (questionnaire, enquête) : délai porté jusqu'à 90 jours.
- Phase contradictoire : 10 jours pour consulter le dossier et faire des observations — à utiliser systématiquement.

Réf. *Art. R.441-7 et suivants.*

Diapo 15 · Silence vaut acceptation

Message clé : Le silence de la CPAM joue en faveur de la victime.

À développer :

- Sans décision dans le délai, le caractère professionnel est reconnu.
- Noter précisément les dates ; ne pas « relancer » au point de provoquer une décision de rejet hâtive.

Réf. *Art. R.441-10.*

Diapo 16 · Intercalaire — Les maladies professionnelles

Message clé : Changer de logique : la MP est progressive.

À développer :

- Annoncer les deux voies de reconnaissance et leur enjeu de preuve.

Diapo 17 · Deux voies de reconnaissance

Message clé : Tableau (présomption) ou CRRMP (preuve du lien).

À développer :

- Voie tableau : si toutes les conditions sont réunies → présomption d'origine, pas besoin de prouver le lien.
- Voie CRRMP : maladie en tableau mais conditions non toutes remplies (lien direct), OU maladie hors tableau (lien direct et essentiel + IPP ≥ 25 % ou décès).

Réf. *Art. L.461-1 CSS (alinéas relatifs au système complémentaire / CRRMP).*

Diapo 18 · Le système des tableaux

Message clé : Savoir lire un tableau de MP.

À développer :

- Trois éléments : désignation de la maladie ; délai de prise en charge après exposition ; liste de travaux (limitative ou indicative).
- Bien repérer les dates d'exposition et l'employeur concerné.

- Où les trouver : INRS et Légifrance (mis à jour régulièrement).

Diapo 19 · Les enjeux actuels

Message clé : Les MP d'aujourd'hui sont surtout des TMS et des atteintes invisibles.

À développer :

- TMS : près de 90 % des MP reconnues ; amiante toujours présente.
- Affections psychiques (burn-out) : souvent hors tableau → passage par le CRRMP.
- Usure professionnelle, expositions chimiques : forte sous-déclaration.

Angle CGT — Faire reconnaître, c'est rendre visible pour pouvoir prévenir et revendiquer.

Diapo 20 · Mise en situation — « Le premier réflexe »

Message clé : Faire appliquer les acquis (cas Karim).

À développer :

- Animation en binômes (15 min) puis restitution.
- Corrigé attendu : information employeur 24 h, CMI détaillé, feuille d'accident, déclaration directe si refus, alerte du CSE et de l'UD.

Diapo 21 · Bilan du jour 1

Message clé : Consolider et préparer le jour 2.

À développer :

- Tour de table : ce que je retiens, ce que je réutiliserai.
- Recueillir les questions en suspens.

JOUR 2 — Indemnisation, séquelles & action syndicale

Diapo 22 · Intercalaire Jour 2

Message clé : Annoncer : après la reconnaissance, la réparation et l'action.

À développer :

- Rappeler le fil : indemnisation → séquelles → faute inexcusable → recours → rôle collectif.

Diapo 23 · Le parcours d'indemnisation

Message clé : Les droits sont plus favorables qu'en maladie « simple ».

À développer :

- IJ majorées : 60 % du salaire journalier de base, puis 80 % à partir du 29e jour d'arrêt.
- Soins pris en charge à 100 % du tarif Sécu ; le jour de l'accident est payé par l'employeur.
- La situation évolue vers la guérison ou la consolidation.

Réf. *Régime AT/MP des indemnités journalières (taux à vérifier au moment de la session).*

Diapo 24 · Guérison ou consolidation ?

Message clé : Notion charnière qui ouvre l'indemnisation des séquelles.

À développer :

- Guérison : retour à l'état antérieur, sans séquelle.
- Consolidation : état stabilisé avec séquelles → c'est là qu'on évalue le taux d'IPP.
- Après consolidation, une rechute ou une aggravation reste possible (nouveau certificat).

Diapo 25 · Indemnisation des séquelles

Message clé : Le seuil de 10 % d'IPP commande tout.

À développer :

- Taux d'IPP < 10 % : indemnité en capital (versée en une fois).
- Taux ≥ 10 % : rente viagère, calculée sur le salaire annuel de référence × « taux utile » (taux diminué de moitié de 10 à 50 %, augmenté de moitié au-delà).
- Le taux est fixé par le médecin-conseil selon un barème indicatif.

Réf. *Salaire annuel de référence encadré par un plancher et un plafond (montants à actualiser).*

> **Angle CGT —** Vérifier systématiquement le taux : un taux sous-évalué, ça se conteste (voir diapo « contester »).

Diapo 26 · Inaptitude et reclassement

Message clé : Protéger l'emploi du ou de la salarié·e.

À développer :

- L'inaptitude est prononcée par le médecin du travail.
- L'employeur a une obligation de reclassement (recherche sérieuse et loyale) ; le CSE est consulté.
- À défaut de reclassement ou de licenciement, l'employeur doit reprendre le versement du salaire après 1 mois.

Réf. *Art. L.1226-10 et suivants (inaptitude d'origine professionnelle).*

Diapo 27 · Inaptitude d'origine professionnelle

Message clé : Des protections financières renforcées.

À développer :

- Indemnité spéciale de licenciement (en principe le double de l'indemnité légale).
- Indemnité compensatrice (équivalente au préavis).
- Tout licenciement doit être motivé par l'impossibilité de reclassement.

Réf. *Art. L.1226-14.*

Diapo 28 · Intercalaire — La faute inexcusable

Message clé : Le levier de la réparation renforcée.

À développer :

- Annoncer : c'est l'outil qui permet d'aller au-delà de l'indemnisation forfaitaire.

Diapo 29 · La faute inexcusable — c'est quoi ?

Message clé : Un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.

À développer :

- L'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger.
- Il n'a pas pris les mesures de protection nécessaires.
- Origine jurisprudentielle (arrêts « amiante » de 2002), assise sur l'obligation de sécurité.

Réf. *Obligation de sécurité : L.4121-1 ; faute inexcusable : L.452-1 et s.*

Diapo 30 · Les effets de la faute inexcusable

Message clé : Une réparation qui se rapproche du préjudice réel.

À développer :

- Majoration de la rente ou du capital (souvent doublement).
- Réparation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, d'agrément, perte ou diminution de promotion professionnelle.
- La CPAM avance les sommes puis les récupère auprès de l'employeur.

Réf. *Majoration : L.452-2 ; préjudices : L.452-3 (élargi par le Conseil constitutionnel en 2010).*

> **Angle CGT —** Levier puissant, mais le dossier se monte avec l'appui juridique de l'UD.

Diapo 31 · La procédure (faute inexcusable)

Message clé : Les étapes et le délai à ne pas manquer.

À développer :

- Action de la victime (ou de ses ayants droit).
- Tentative de conciliation auprès de la CPAM, puis saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
- Prescription : 2 ans — d'où l'urgence d'agir.

Diapo 32 · Contester une décision

Message clé : Deux circuits selon la nature du litige.

À développer :

- Contestation d'ordre médical (taux d'IPP, état de santé) : commission médicale de recours amiable, puis pôle social.
- Autres litiges : pôle social du tribunal judiciaire.
- Les délais de recours sont courts : agir sans attendre.

Diapo 33 · La prescription

Message clé : Surveiller les délais, c'est le réflexe vital.

À développer :

- En AT/MP, beaucoup d'actions se prescrivent par 2 ans.
- Repérer le point de départ du délai au cas par cas.
- En cas de doute : saisir tôt l'UD et, si besoin, un avocat.

Diapo 34 · Intercalaire — Rôle du CSE/CSSCT et du syndicat

Message clé : Passer du dossier individuel à l'action collective.

À développer :

- Annoncer : c'est ici que la formation prend tout son sens syndical.

Diapo 35 · Les leviers du CSE / CSSCT

Message clé : Des outils concrets et opposables.

À développer :

- Enquête du CSE après un AT (notamment grave).
- Droit d'alerte en cas de danger grave et imminent ; droit de retrait du ou des salarié·es.
- Analyse et mise à jour du DUERP ; recours possible à une expertise.

Réf. *Enquêtes : L.2312-13 ; alerte/retrait : L.4131-1 et s. ; DUERP : R.4121-1.*

Diapo 36 · L'enquête : l'arbre des causes

Message clé : Une méthode pour comprendre, pas pour accuser.

À développer :

- Recueillir les faits immédiatement, sans chercher de coupable.
- Remonter les causes : techniques, humaines, organisationnelles (logique multicausale).
- Aboutir à des mesures de prévention, puis en assurer le suivi.

> **Angle CGT —** Refuser l'explication paresseuse par « l'erreur humaine » : presque toujours, l'organisation est en cause.

Diapo 37 · Du cas individuel au collectif

Message clé : La finalité syndicale de la démarche.

À développer :

- Chaque AT/MP révèle un problème d'organisation du travail.
- En faire une revendication : effectifs, cadences, matériel, formation, aménagements.

- Inscrire les mesures au DUERP et au programme annuel de prévention.

Diapo 38 · Mise en situation — « De l'accident à la prévention »

Message clé : Mettre en pratique l'enquête et la revendication.

À développer :

- Cas d'un AT grave sur une ligne de production.
- Construire collectivement : enquête (arbre des causes), suites DUERP, revendication.

Diapo 39 · Évaluation et bilan des 2 jours

Message clé : Mesurer les acquis et préparer la suite.

À développer :

- Évaluation à chaud, puis à froid (2 à 3 mois après).
- Chacun repart avec un mini plan d'action ; organiser l'essaimage dans les UD.

Diapo 40 · Ressources utiles

Message clé : Où trouver l'information fiable.

À développer :

- ameli.fr (Assurance Maladie – Risques professionnels) : procédures, formulaires, feuille d'accident.
- Légifrance : L.411-1, L.411-2, R.441-2, R.441-10, L.452-1 et s., tableaux de MP.
- INRS : tableaux, prévention, risques par métier ; service-public.fr.
- CGT : collectif santé au travail de l'UD et appui juridique.

Diapo 41 · Clôture — Merci

Message clé : Ouvrir sur l'action.

À développer :

- Donner les contacts de l'UD et du collectif santé au travail.
- Encourager chacun à accompagner un premier dossier et à revenir vers le réseau CGT.